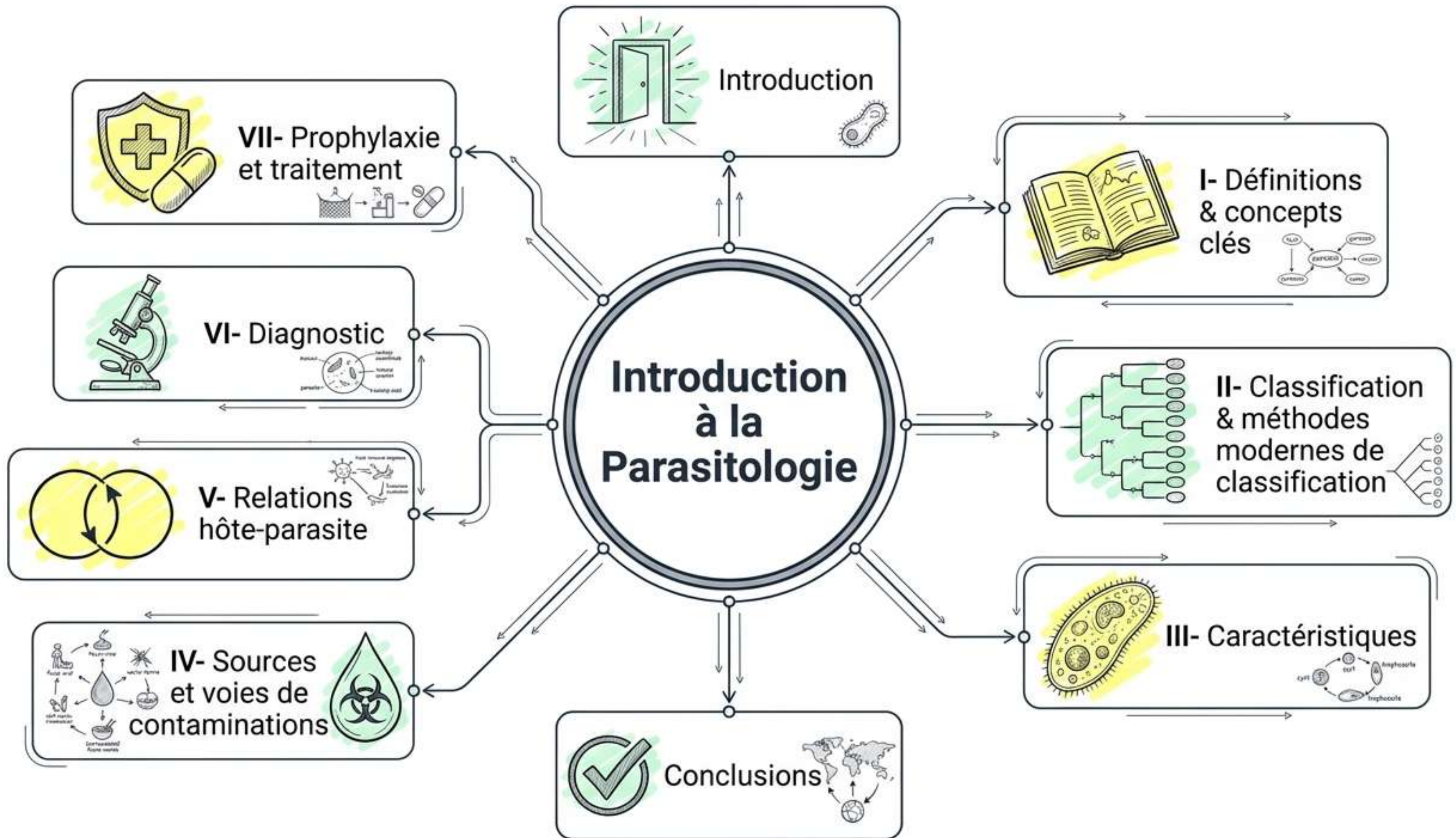
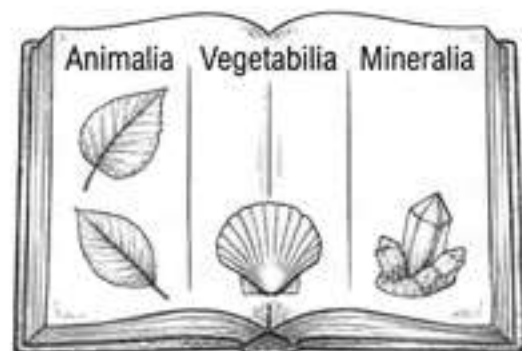


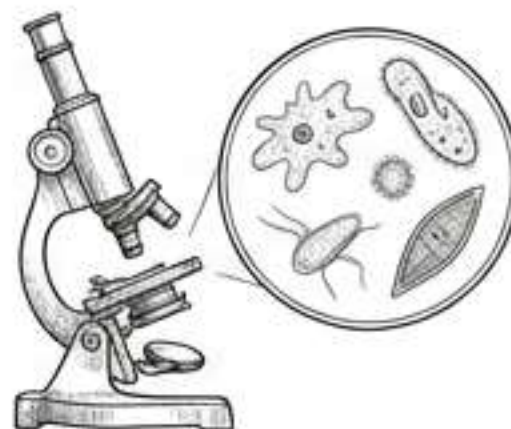


Chronologie de la classification :



1735 : Carl von Linné publie *Systema Naturae* (3 catégories : animal, végétal, minéral).

1876 : Invention du microscope optique → découverte des unicellulaires → création du règne Protista (minéraux exclus).



1949 : Introduction du règne Fungi (champignons).



Actuellement : Individualisation de six règnes (ajout des Archées et Bactéries).

les Six Règnes du Monde Vivant

Eucaryotes

Champignons

Plantes

Protistes

Animaux

Procaryotes

Bactéries

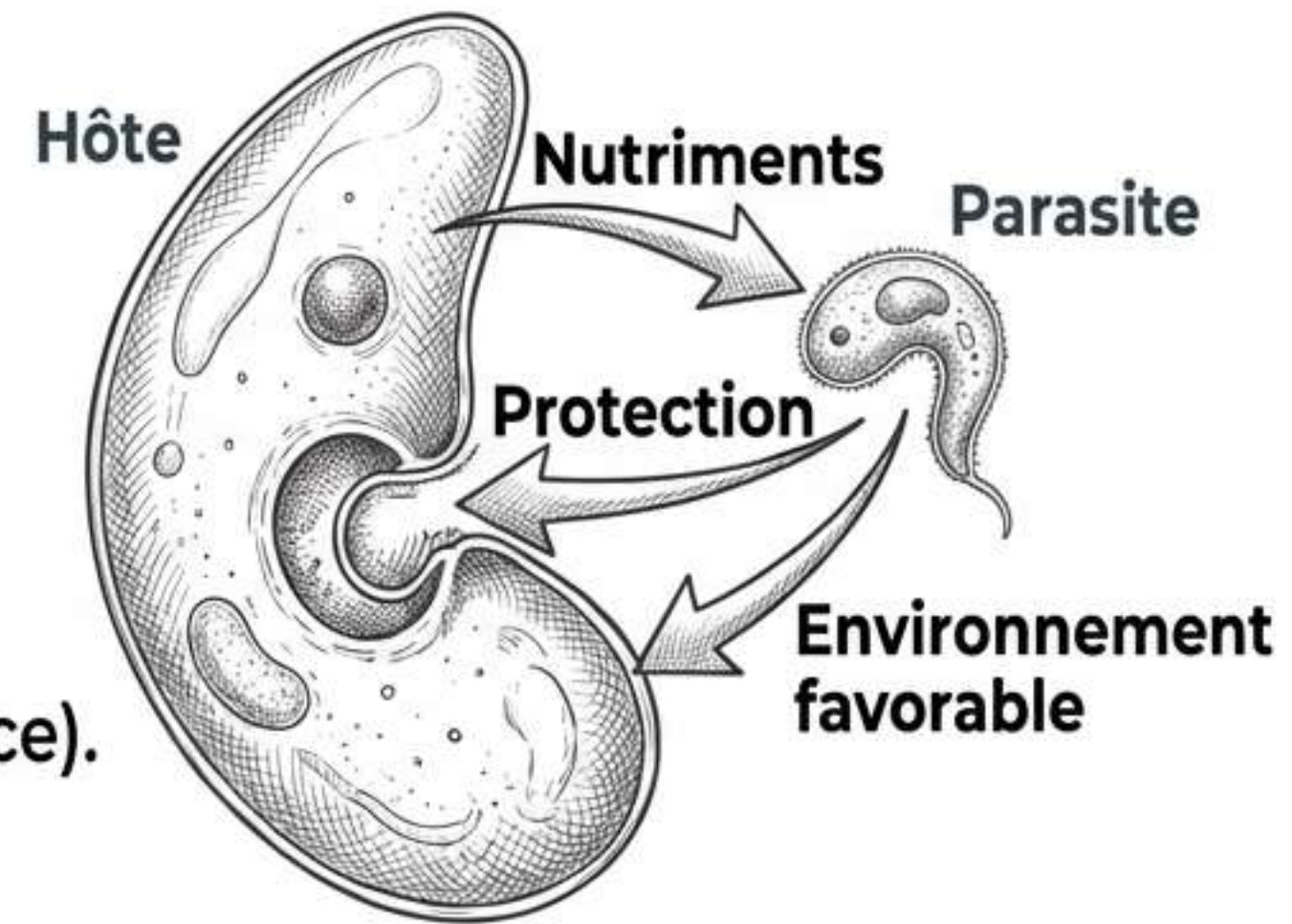
Archées

Les deux grands groupes du vivant :

- Les eucaryotes : organismes dotés de cellules possédant un véritable noyau. [Ref: Q4]
- Les procaryotes : organismes unicellulaires dépourvus de noyau.

I- Définitions : Le Parasite

- **Organisme eucaryote**, unicellulaire ou pluricellulaire. [Ref: Q4]
- Vit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un hôte.
- Prélève des nutriments (temporairement ou en permanence).
- Provoque des maladies : les parasitoses.



Deux grands types de parasites :

- Les **protozoaires** : unicellulaires, mobiles (pseudopodes, flagelles, cils) ou immobiles. **En chirurgie dentaire, seuls les protozoaires nous intéressent.** [Predicted - Clinical boundary frequently tested]
- Les **métazoaires** : pluricellulaires, dotés de tissus bien différenciés.

L'Hôte :

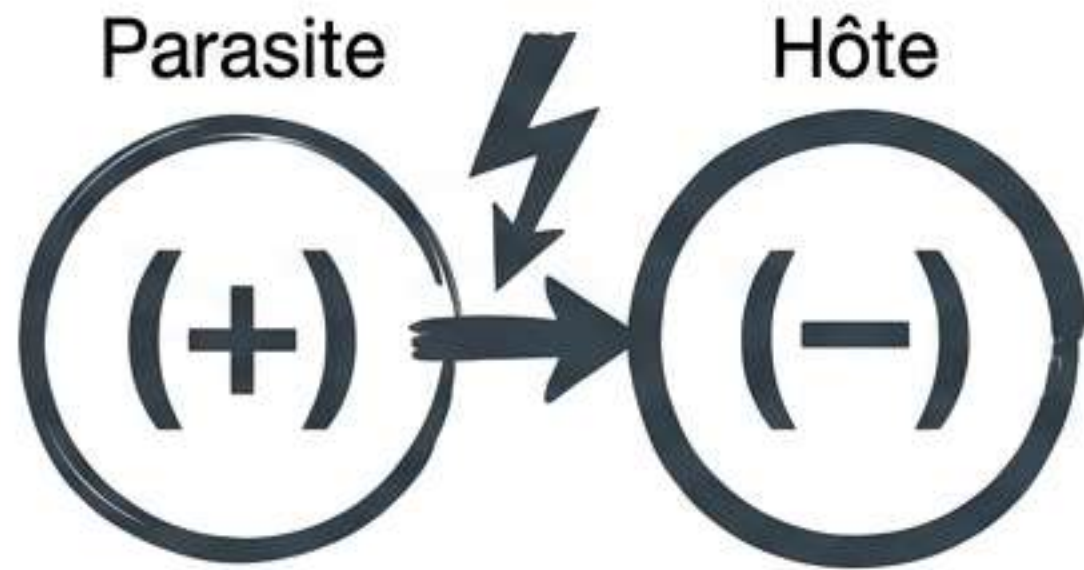
- Organisme hébergeant le parasite (fournit nutriments, protection, environnement).

Parasitologie médicale :

- Science étudiant le cycle de vie, la biologie, les parasitoses, le diagnostic, la prévention et le traitement.

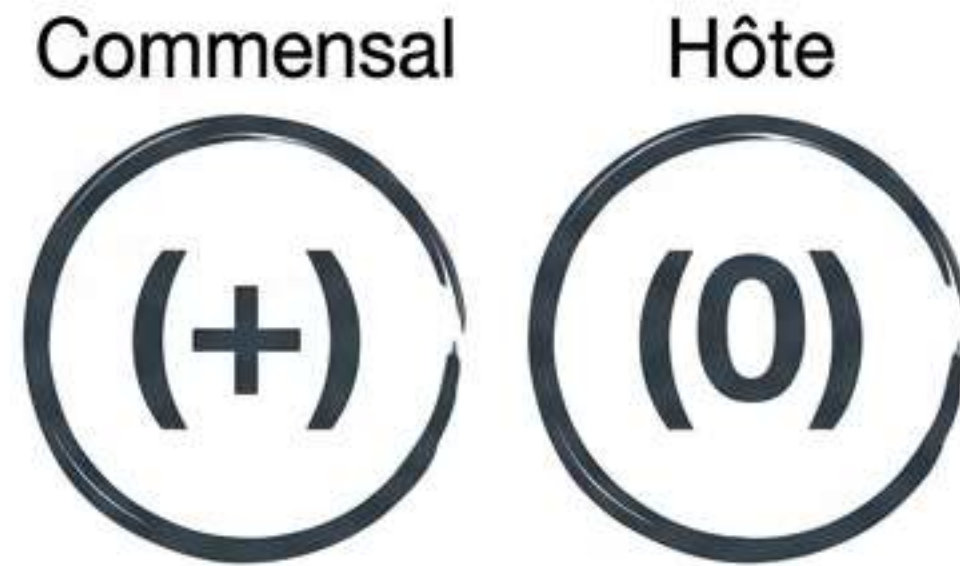
La Symbiose : Relations étroites entre différentes espèces, classées selon l'effet produit.

1. Le parasitisme



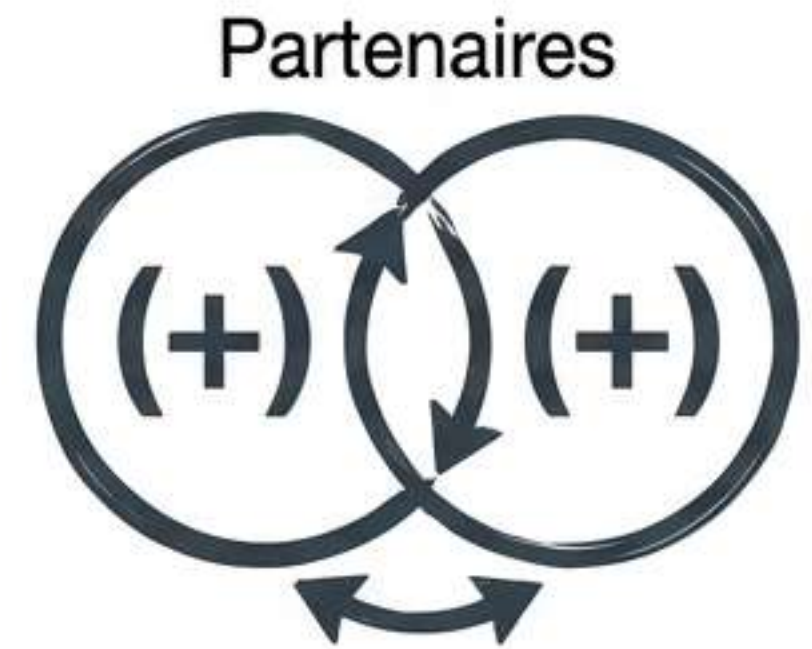
Mode de vie où un organisme (le parasite) vit aux dépens d'un autre (l'hôte). [Ref: Q1]
Un seul tire profit, souvent au détriment de l'hôte. [Ref: Q1]
Association temporaire ou permanente, causant des troubles (parasitoses). [Ref: Q1]

2. Le commensalisme



- Un seul tire un avantage.
- L'hôte n'en tire ni bénéfice ni dommage (sans nuire).

3. Le mutualisme



- Association bénéfique pour les deux partenaires.
- Chacun en tire profit (temporaire ou permanente).

II- Méthodes modernes de classification :

XVIII^e siècle : Phénotypie (caractères visibles à l'œil nu, par Carl von Linné).



XIX^e siècle : Critères microscopiques (invention du microscope).



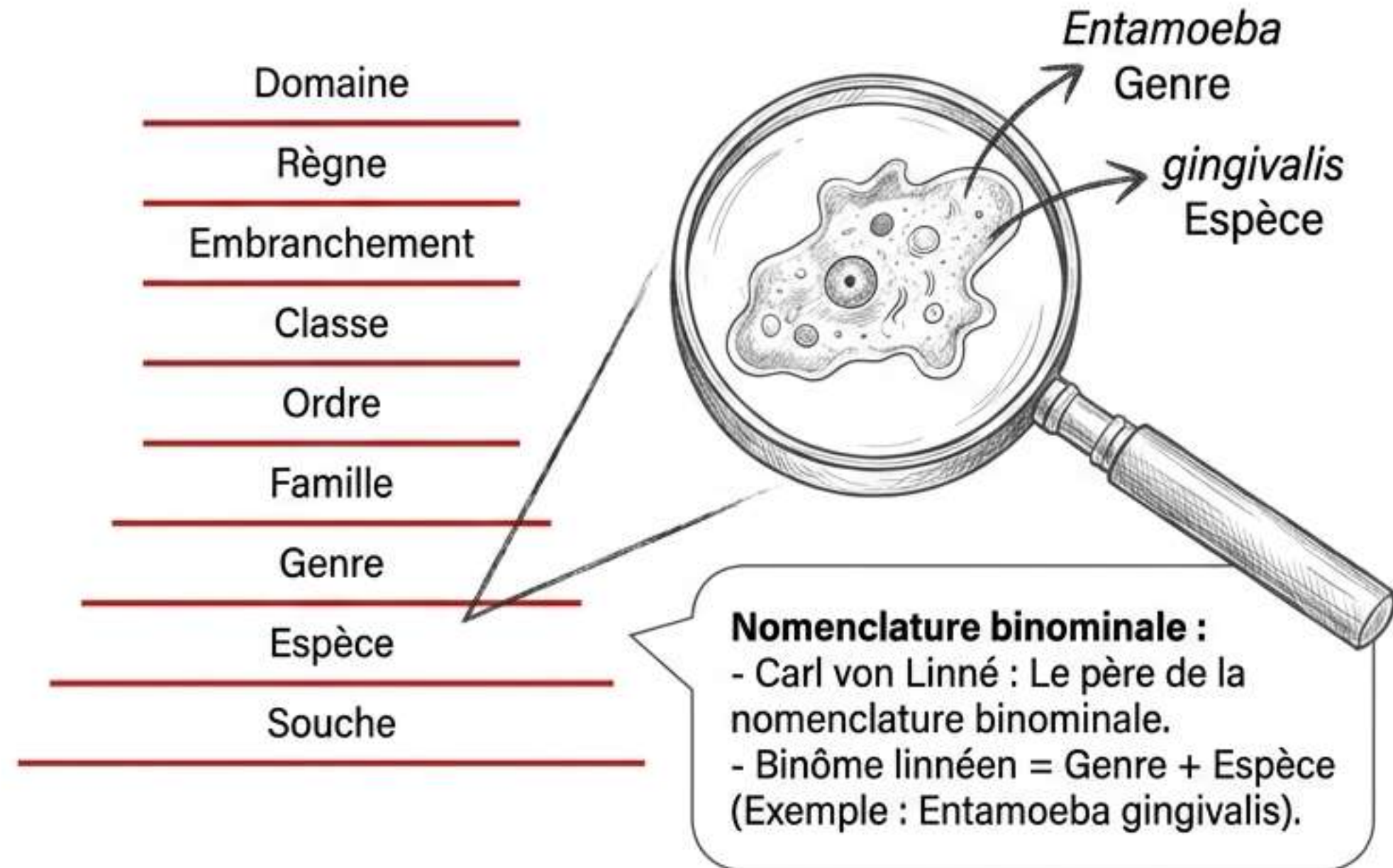
XX^e siècle : Génotypie (biologie moléculaire et génomique).



Actuellement : Protéomique (analyse des protéines via spectrométrie de masse).

La Systématique Taxonomique :

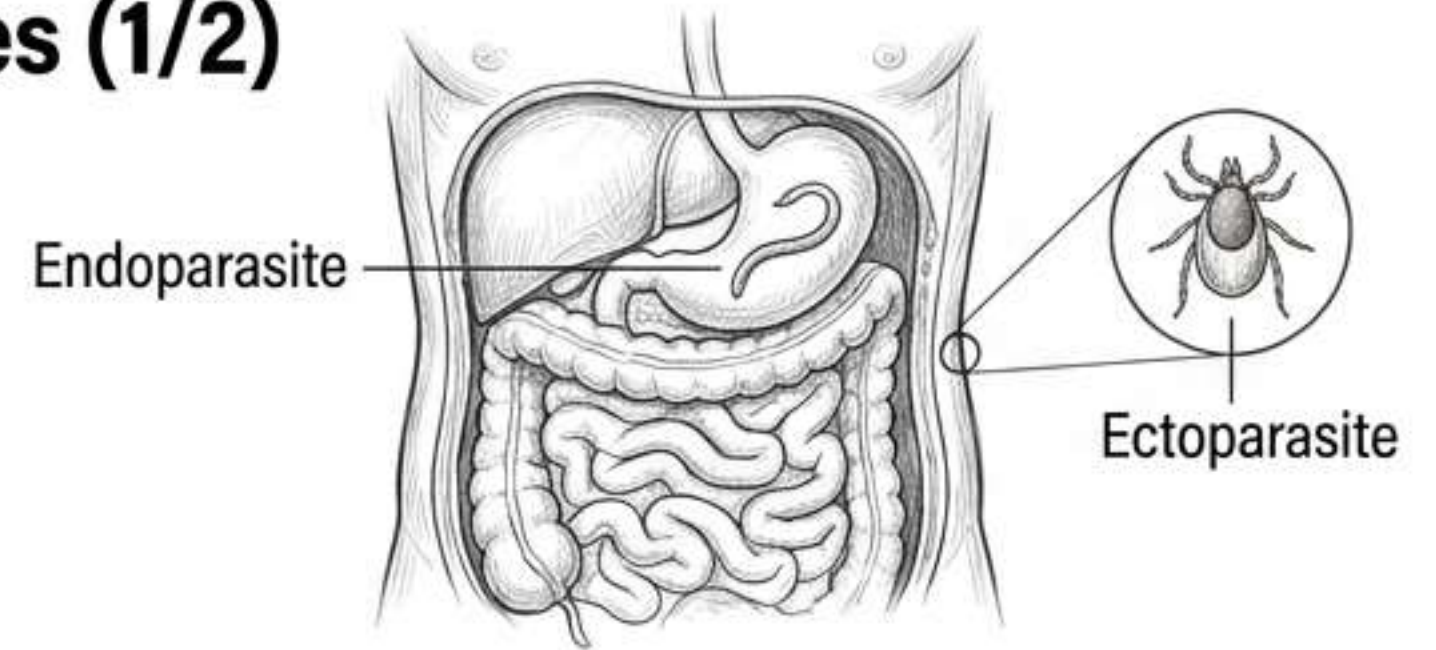
Classée du plus complexe au plus simple : **Domaine > Règne > Embranchement > Classe > Ordre > Famille > Genre > Espèce > Souche**. [Predicted - Ordering sequence MCQ target]



III- A. Caractéristiques biologiques des parasites (1/2)

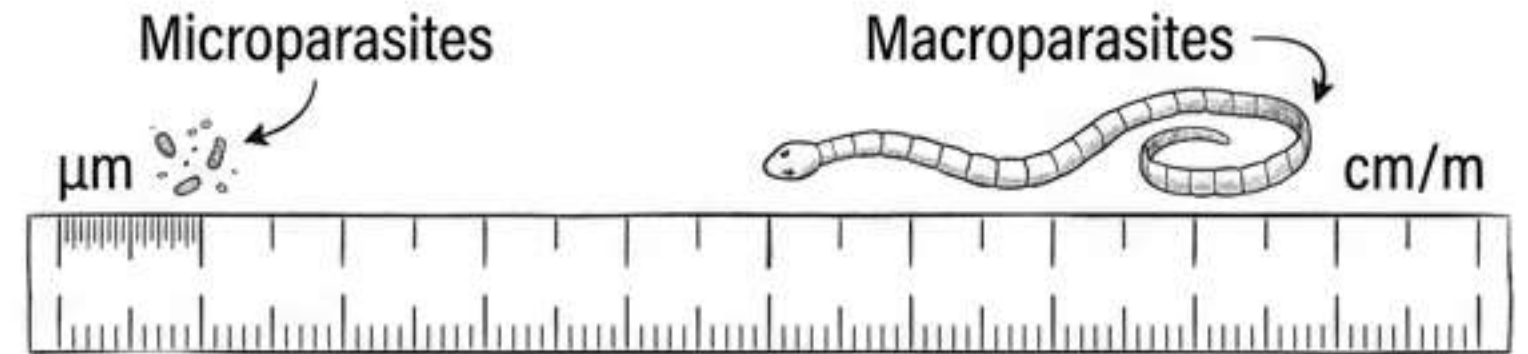
1. Localisation :

- Endoparasites : vivent à l'intérieur de l'hôte.
- Ectoparasites : vivent à l'extérieur de l'hôte.



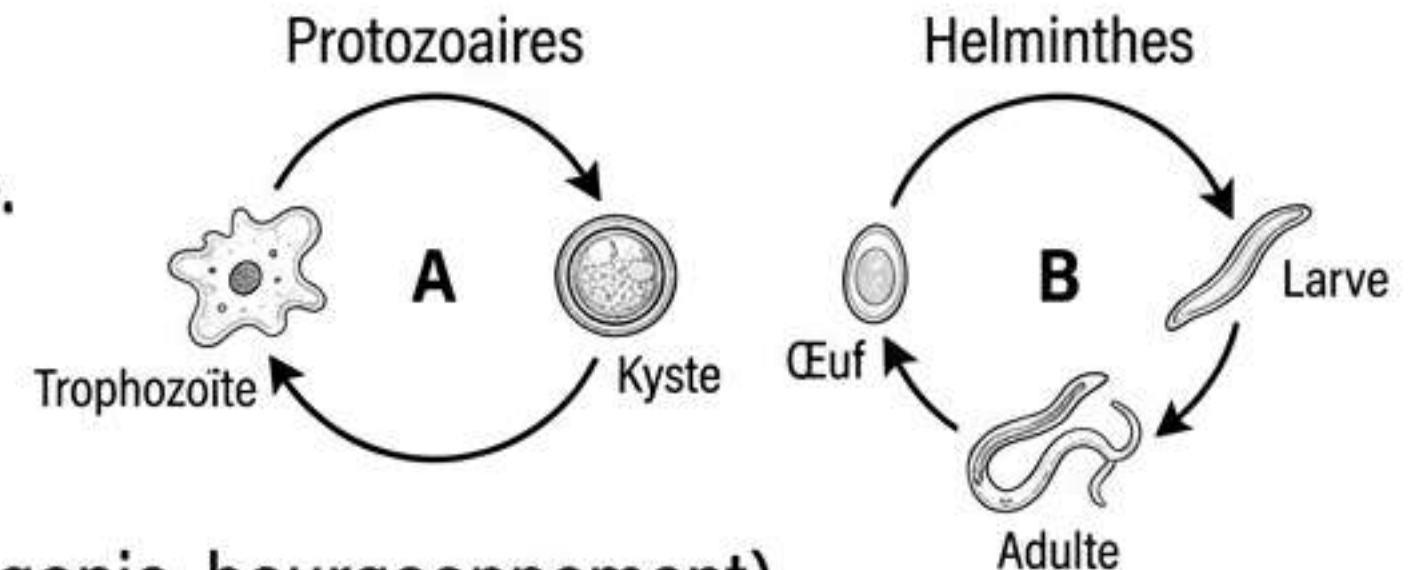
2. Taille :

- Macroparasites : centimètres à plusieurs mètres.
- Microparasites : de l'ordre du micromètre.



3. Formes parasitaires :

- Protozoaires : forme végétative (trophozoïte) et forme kystique.
- Helminthes : forme œuf, larvaire et adulte.



4. Mode de reproduction :

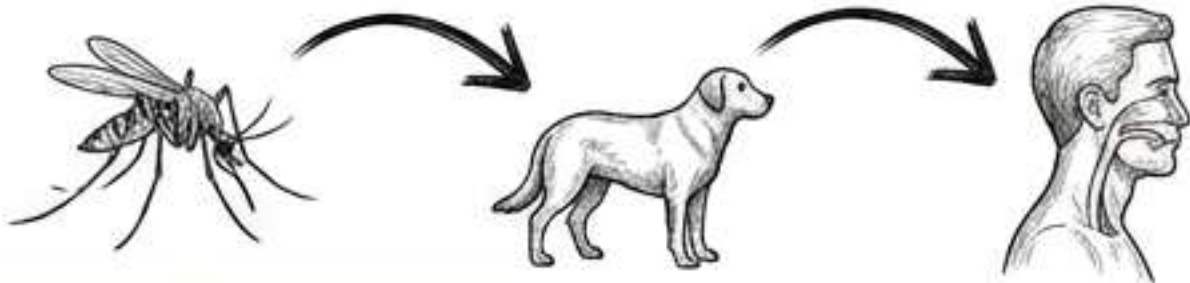
- Protozoaires : Majoritairement asexuée (division binaire, schizogonie, bourgeonnement).
Exception : voie sexuée chez les sporozoaires (coccidies). [Predicted - Exception testing]
- Métazoaires : asexuée, sexuée, ou hermaphrodite (deux sexes sur le même individu).

III- A. Caractéristiques biologiques des parasites (2/2)

5. Cycle évolutif : Succession ordonnée de stades



Cycle Monoxène : se déroule chez un seul hôte.



Cycle Hétéroxène : implique plusieurs hôtes.

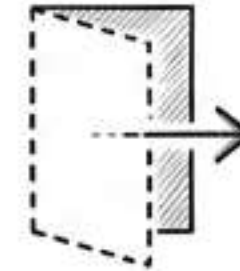
6. Pathogénicité : (Provoque une maladie)

- **Pathogène primaire** : infecte un hôte sain.
- **Pathogène opportuniste** : infecte un hôte affaibli ou immunodéprimé.

7. Types de parasitisme (Dépendance à l'hôte)



Obligatoires (holoparasites) :
vivent uniquement chez un hôte.



Facultatifs : peuvent vivre avec ou
sans hôte.



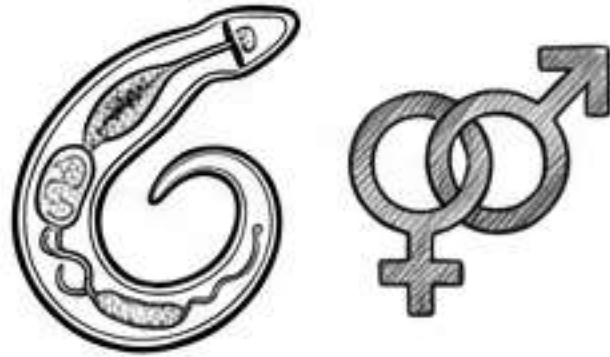
Accidentels : infectent un hôte
inhabituel (le cycle ne peut s'y
compléter).



Errants (migrants) : se développent
anormalement dans un hôte non
adapté.

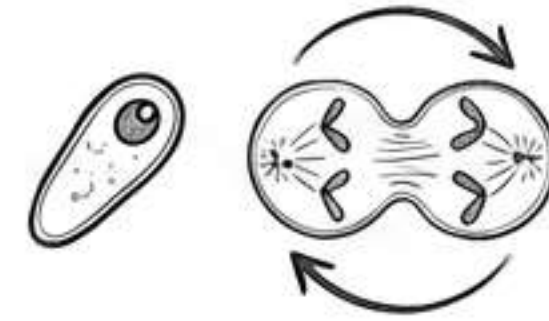
III- B. Caractéristiques de l'Hôte : Rôles dans le cycle

1. Hôte définitif :



Héberge le parasite jusqu'à sa maturité.
Lieu de la reproduction sexuée.

2. Hôte intermédiaire (HI) :



Héberge le parasite à un stade non adulte.
Lieu de la reproduction asexuée.

3. Hôte accidentel :



Héberge exceptionnellement un parasite vivant normalement chez un autre hôte.

4. Réservoir :



Porteur sain du parasite : il assure sa survie et sa transmission sans manifester de maladie.
[Predicted - Important epidemiological concept]



IV- Sources de contaminations et Voies de transmission

1. Les Sources



L'eau et les aliments : transmission hydrique ou alimentaire.



L'homme : maladies anthroponotiques (anthroponoses).



Les animaux : zoonoses (de l'animal à l'homme).



L'environnement : contact avec le sol, les végétaux, éléments contaminés.

2. Les Voies de transmission à l'homme



Voie orale : ingestion d'eau/aliments contaminés.



Voie vectorielle : par un vecteur vivant (insecte, ex: Anophèles pour le paludisme).



Voie transcutanée : passage à travers la peau.



Voie iatrogène : lors d'actes médicaux (ex: transfusions sanguines).



Voie verticale : de la mère à l'enfant pendant la grossesse (ex: toxoplasmose).

V-1. Relation hôte-parasite : Actions du parasite

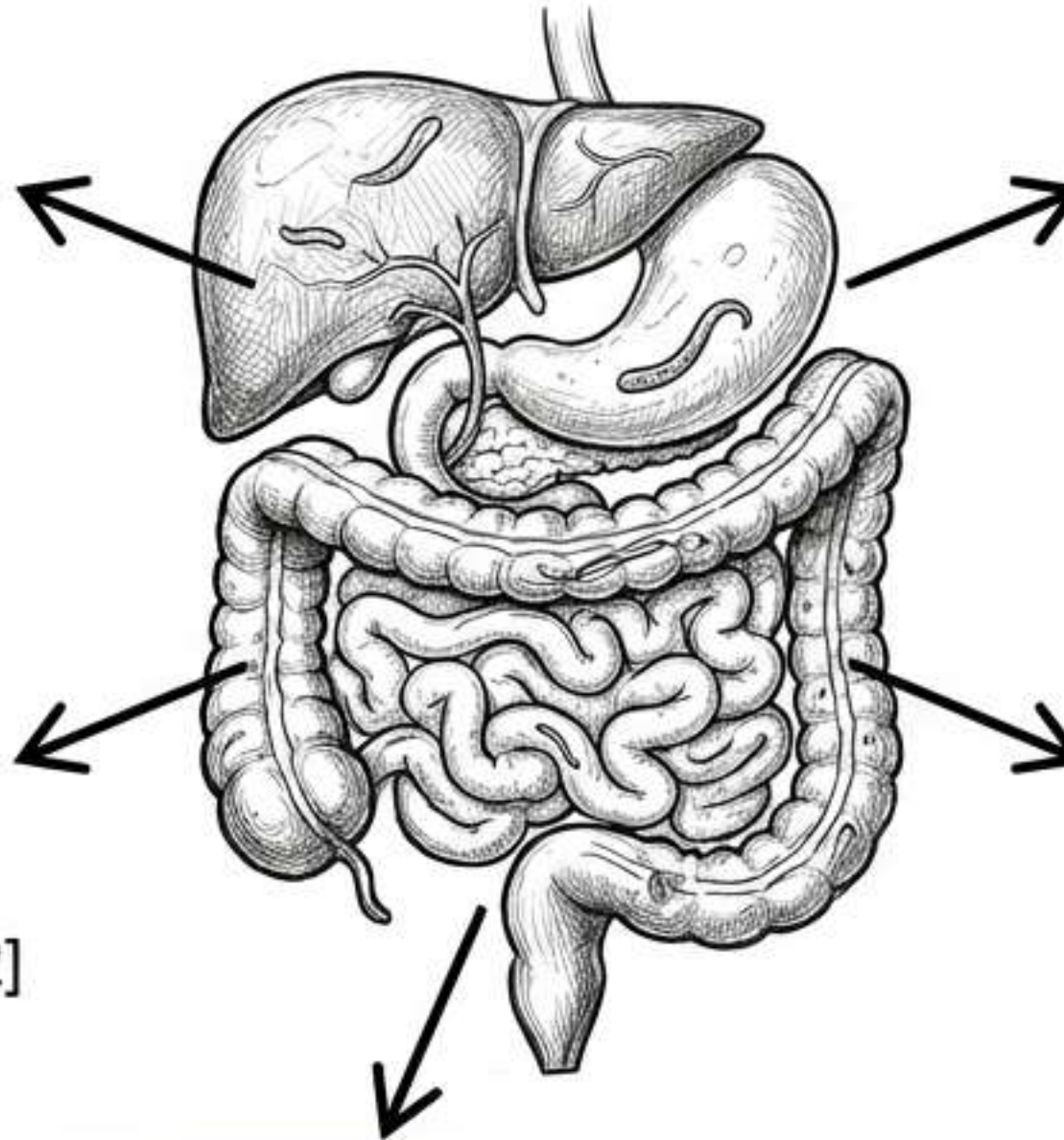
Les parasites nuisent à l'hôte selon plusieurs mécanismes d'action :



Action mécanique : obstrue ou comprime certains organes (canaux biliaires/intestinaux), provoquant des troubles fonctionnels. [Ref: Q2]



Action spoliatrice : se nourrit des nutriments de l'hôte (fer, vitamines, glucose...), entraînant dénutrition/carences. [Ref: Q2]



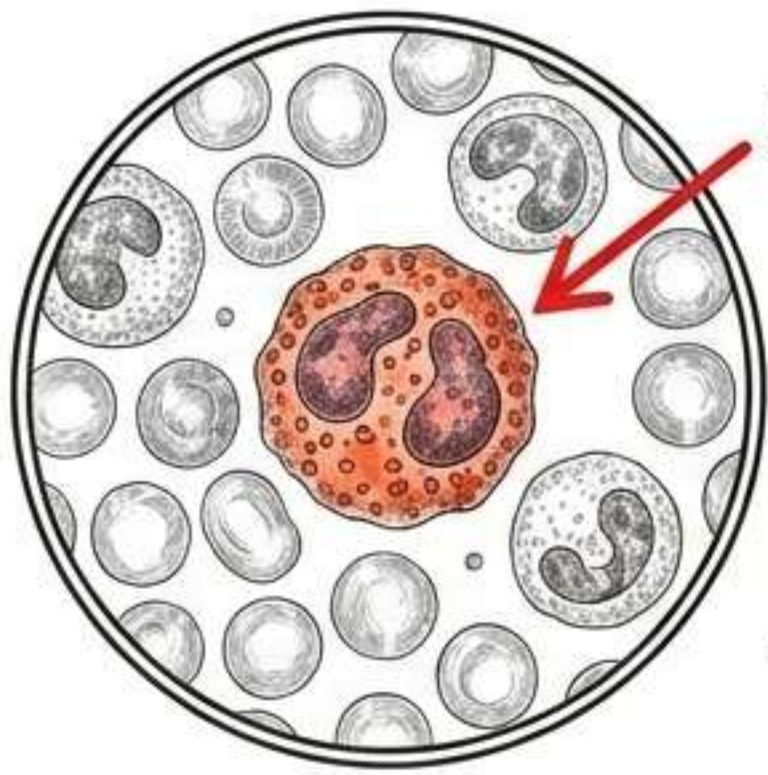
Action traumatique : endommage directement les tissus en les perforant/déplaçant (crée lésions ou ulcérations). [Ref: Q2]



Action irritative et inflammatoire : présence du parasite ou de ses déchets métaboliques provoque irritation locale et réponse inflammatoire. [Ref: Q2]



Action toxique : libération de substances toxiques (métabolites ou enzymes) aux effets délétères sur les cellules/organes. [Ref: Q2]



Éosinophile

V-2. Réaction de l'hôte face au parasite :

Éosinophilie sanguine : Fréquemment observée lors des infections par les métazoaires, mais généralement absente lors des infections à protozoaires. [Predicted - Crucial biological differentiation]

V-3. Facteurs influençant la relation :

L'Hôte

Facteurs influençant : L'âge, l'état nutritionnel et le statut immunitaire.

Réactions non spécifiques :

Réponses tissulaires (inflammatoires, métaplasies, hyperplasies, néoplasies).

Réponse immunitaire spécifique :

À médiation humorale (anticorps) ou cellulaire (lymphocytes T).



Le Parasite

Facteurs influençant : Forte capacité d'adaptation, modification de la morphologie, multiplication rapide.

Mécanismes d'échappement :

Permettent de déjouer les défenses immunitaires pour assurer survie et persistance.

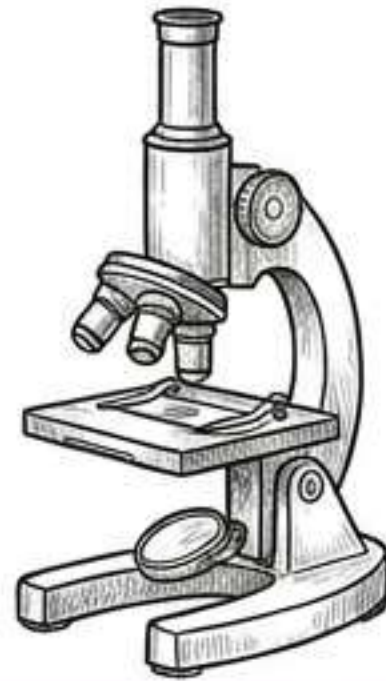
VI- Diagnostic des parasitoses

1. Le prélèvement



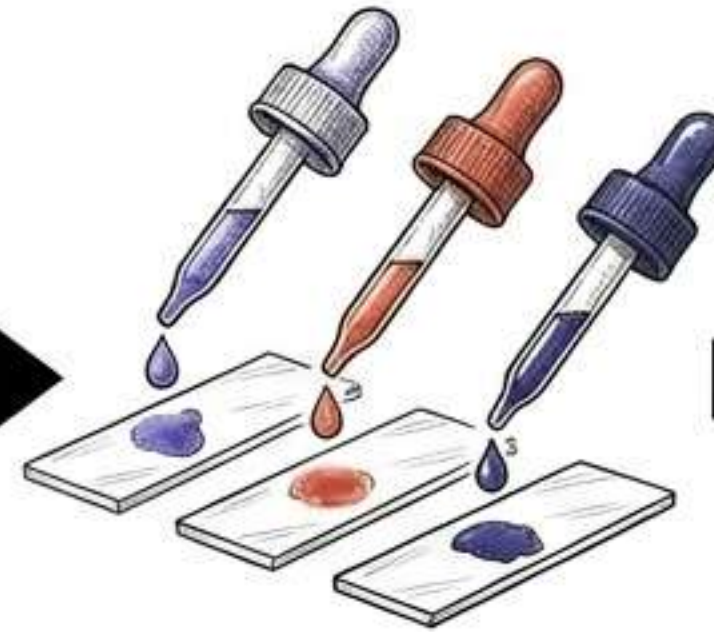
Doit être de qualité et suffisant. Variés : écouvillonnage, lavage-aspiration, curetage, ou insertion d'une pointe de papier dans une poche parodontale. [Ref: Q3]

2. L'Examen microscopique direct



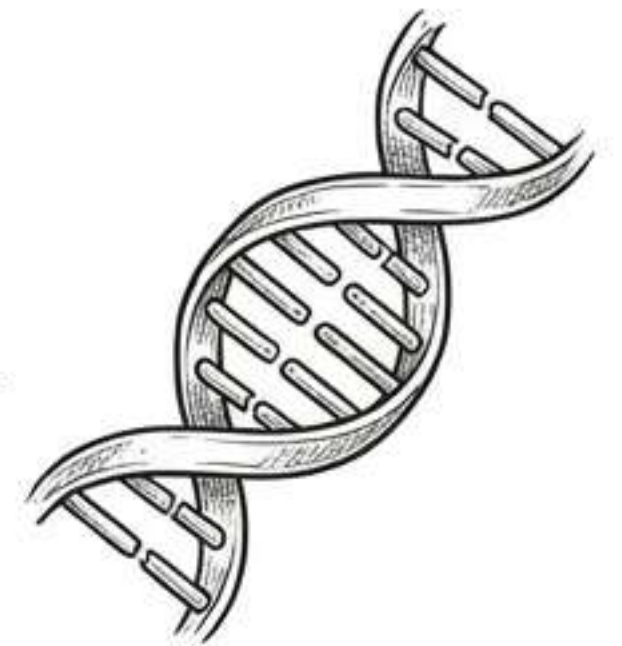
Montage entre lame et lamelles. Nécessite un œil expérimenté.
Un seul examen négatif n'élimine pas une parasitose. [Ref: Q3]

3. L'Examen microscopique après colorations



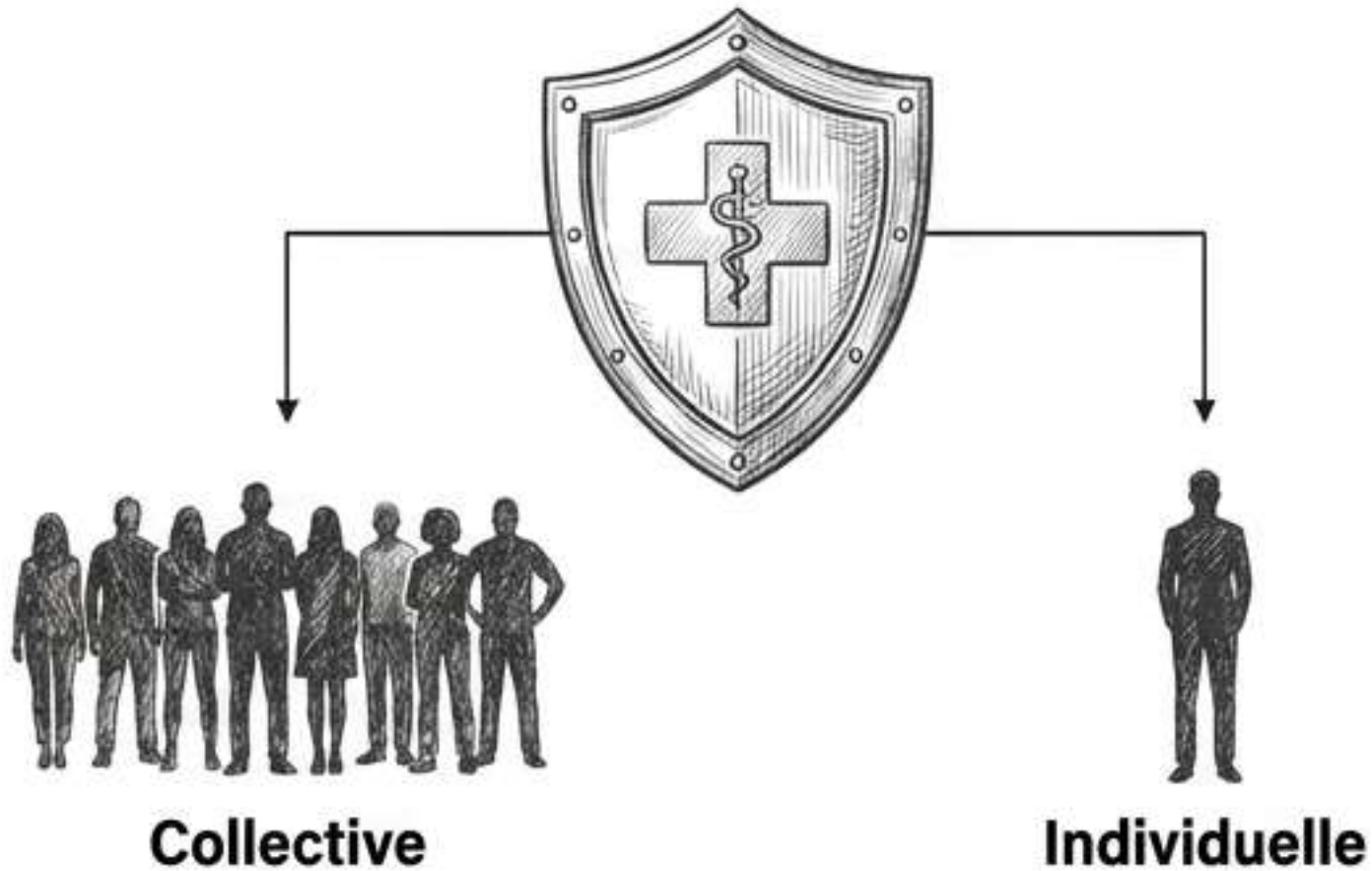
Permet l'identification caractéristique via : Giemsa, trichrome, hématoxyline ferrique.

4. La culture et la biologie moléculaire



Ne sont pas de pratique systématique [Ref: Q3] (réservées aux laboratoires spécialisés). Utilisation de milieux spécifiques ou la PCR.

VII- Prophylaxie



Sur l'hôte : Amélioration de l'hygiène et éducation sanitaire.

Sur le parasite : Traitement approprié, diagnostic précoce et dépistage.

La Prophylaxie : Vise à prévenir l'infection (individuelle ou collective).

VII- Traitement en médecine dentaire



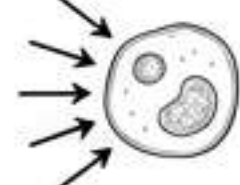
En thérapeutique dentaire, la molécule principale utilisée est le Métronidazole. [Predicted - Direct pharmacological target for exam]

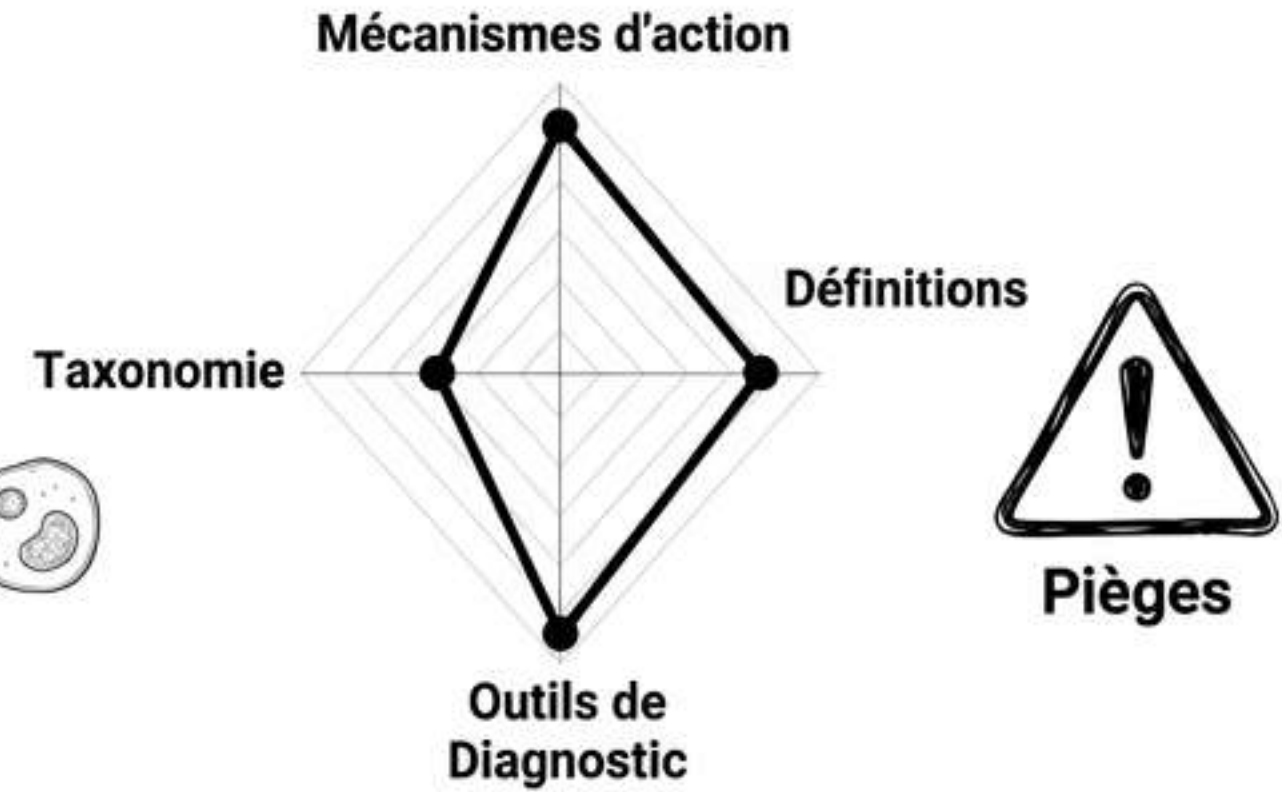
Conclusions :

- La parasitologie médicale bucco-dentaire révèle l'importance des parasites colonisant la cavité buccale.
- Une bonne maîtrise permet au chirurgien-dentiste une prise en charge globale, améliorant le diagnostic et les soins.

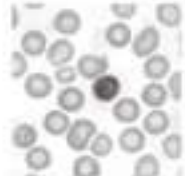
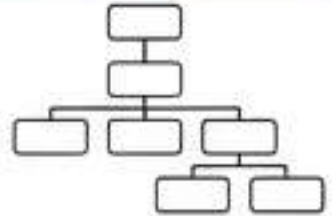
Exam Pattern Analysis : Stratégies de révision

Thèmes les plus répétés (Zones rouges) :

- **Définitions de Symbiose** : Ne confondez pas. Le parasitisme cause des troubles de manière **unilatérale** (1 tire profit). 
- **Mécanismes d'action (V-1)** : Les examinateurs testent les 5 actions exactes. **Piège** : L'action 'métabolique' n'existe pas. 
- **Le Diagnostic** : Différencier l'obligatoire (Examen direct) du facultatif (La PCR **n'est pas systématique**).  



Cibles futures hautement probables (Prédictions) :

- **L'éosinophilie sanguine** : Marqueur différentiel (Métazoaires = Oui / Protozoaires = Non).  
- **La hiérarchie taxonomique** : Mémoriser l'ordre exact (Domaine → Souche). 
- **Pharmacologie** : Le **Métronidazole** en dentaire.  

Piège Absolu :

Ne qualifiez jamais les parasites de procaryotes ou de bactéries.
Ce sont strictement des **Eucaryotes**.

